

MÉDECINE LÉGALE · ÉTHIQUE · MÉDECINE DU TRAVAIL · DÉONTOLOGIE

Fiches QE Haute Fréquence — Module transversal FMPM — Version 1

Cross-match : 550 QEs officielles (Mai 2016 → Rattrapage 2025) × Cours officiels FMPM : [ethique-aio.pdf](#) · [med-legal-aio.pdf](#) · [med-travail-aio.pdf](#)

Module transversal — FMPM Marrakech · [corrections officielles e-qe.online](#)

PARTIE 1 — CLASSEMENT DES LEÇONS PAR ORDRE D'IMPORTANCE

Classement basé sur la fréquence réelle dans 550 QEs (13 sessions).

Rang	Leçon officielle	Total	Professeur
1	Éthique et recherche	49 Q	Éthique/Déonto.
2	Risque professionnel en milieu de soins	41 Q	Médecine travail
3	Introduction et principes de l'éthique	39 Q	Éthique/Déonto.
4	Forme médico-légale de la mort : certificat de décès	36 Q	Médecine légale
5	Responsabilité médicale	30 Q	Médecine légale
6	Phénomènes cadavériques et datation	29 Q	Médecine légale
7	Levée du corps et autopsie	28 Q	Médecine légale
8	Éthique et santé publique	25 Q	Éthique/Déonto.
9	Réparation maladies professionnelles + AT	22 Q	Médecine travail
10	Code de déontologie	19 Q	Éthique/Déonto.
11	Agressions sexuelles	19 Q	Médecine légale
12	Justice et équité	18 Q	Éthique/Déonto.
13	Prélèvement et transplantation d'organe	18 Q	Médecine légale
14	Blessure (traumatologie ML)	17 Q	Médecine légale
15	Séviages à enfant + infanticide	16 Q	Médecine légale
16	Rôles et missions du médecin du travail	15 Q	Médecine travail
17	Certificats médicaux	14 Q	Médecine légale
18	Asphyxies mécaniques	14 Q	Médecine légale
19	Éthique et fin de vie	11 Q	Éthique/Déonto.
20	Éthique et procréation	10 Q	Éthique/Déonto.
21	Dermatoses professionnelles	10 Q	Médecine travail
22	Troubles musculo-squelettiques (TMS)	10 Q	Médecine travail
23	Éthique et don d'organe	8 Q	Éthique/Déonto.
24	Pneumopathies professionnelles	8 Q	Médecine travail
25	Accident d'exposition au sang (AES)	8 Q	Médecine travail

Rang	Leçon officielle	Total	Professeur
26	Risques psychosociaux (RPS)	8 Q	Médecine travail
27	Surdité professionnelle	7 Q	Médecine travail
28	Consentement du patient	6 Q	Éthique/Déonto.
29	Questions inclassifiables (transversales)	4 Q	Transversal
30	Radioprotection	4 Q	Médecine travail
31	Abstention fautive (non-assistance)	4 Q	Médecine légale
32	Introduction à la médecine légale	2 Q	Médecine légale
33	Contrat médical	1 Q	Médecine légale

PARTIE 2 — MOYENNE DE QUESTIONS PAR LEÇON PAR EXAMEN

Statistiques calculées sur 13 sessions, chaque examen ~42.3 questions.

Leçon officielle	Total	Moylexam	% d'examen
Éthique et recherche	49	3.77	8.9%
Risque professionnel en milieu de soins	41	3.15	7.4%
Introduction et principes de l'éthique	39	3.00	7.1%
Forme médico-légale de la mort : certificat de décès	36	2.77	6.5%
Responsabilité médicale	30	2.31	5.5%
Phénomènes cadavériques et datation	29	2.23	5.3%
Levée du corps et autopsie	28	2.15	5.1%
Éthique et santé publique	25	1.92	4.5%
Réparation maladies professionnelles + AT	22	1.69	4.0%
Code de déontologie	19	1.46	3.5%
Agressions sexuelles	19	1.46	3.5%
Justice et équité	18	1.38	3.3%
Prélèvement et transplantation d'organe	18	1.38	3.3%
Blessure (traumatologie ML)	17	1.31	3.1%
Séviçes à enfant + infanticide	16	1.23	2.9%
Rôles et missions du médecin du travail	15	1.15	2.7%
Certificats médicaux	14	1.08	2.6%
Asphyxies mécaniques	14	1.08	2.6%
Éthique et fin de vie	11	0.85	2.0%
Éthique et procréation	10	0.77	1.8%
Dermatoses professionnelles	10	0.77	1.8%
Troubles musculo-squelettiques (TMS)	10	0.77	1.8%
Éthique et don d'organe	8	0.62	1.5%
Pneumopathies professionnelles	8	0.62	1.5%
Accident d'exposition au sang (AES)	8	0.62	1.5%
Risques psychosociaux (RPS)	8	0.62	1.5%
Surdité professionnelle	7	0.54	1.3%
Consentement du patient	6	0.46	1.1%
Questions inclassifiables (transversales)	4	0.31	0.7%
Radioprotection	4	0.31	0.7%
Abstention fautive (non-assistance)	4	0.31	0.7%
Introduction à la médecine légale	2	0.15	0.4%
Contrat médical	1	0.08	0.2%

Leçon officielle	Total	Moy/exam	% d'exam
TOTAL des 33 leçons officielles	550 Q	42.3	100%

PARTIE 3 — QUESTIONS LES PLUS FRÉQUENTES (ORDRE STRICT PAR RANG)

Format : faits (-) / pièges (Δ) / source (□) / lien cours (□) / citations (□)

[RANG 1] ÉTHIQUE ET RECHERCHE

— • ~3.77 Q/examen

□ Source : *ethique-aio.pdf* — Éthique & Déontologie FMPM

Les 3 principes du Rapport de Belmont (1979) — la distinction la plus testée :

- Respect des personnes → autonomie + consentement éclairé + vie privée
- Bienfaisance / Non-malfaisance → MAXIMISER les bénéfices, MINIMISER les risques
- Justice → ÉVITER L'EXPLOITATION + sélection équitable des sujets
- Δ Piège récurrent : « justice = minimiser les risques » → FAUX (c'est non-malfaisance)
- Δ « non-malfaisance = éviter l'exploitation » → FAUX (c'est la justice)
- Δ Le VOLONTARIAT concrétise le RESPECT DE L'AUTONOMIE (pas la bienfaisance)

□ Vu : R2025 Q11-12, N2025 Q15, M2022 Q41, M2020 Q44-48, Nov2024 Q11 (≥10×)

Documents historiques de l'éthique de la recherche :

- Code de Nuremberg (1947) — suite aux expériences nazies sur les prisonniers ; a imposé le CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ
- Déclaration d'Helsinki (1964, AMM) ; Rapport de Belmont (1979, 3 principes)
- Δ Charte d'Ottawa & déclaration d'Alma-Ata = promotion de la santé / soins primaires — JAMAIS la réponse en éthique de la recherche
- Δ Chez les prisonniers, c'est le VOLONTARIAT qui est compromis (coercition)

□ Vu : R2025 Q16, Jun2024 Q44-45, Jul2024 Q44-45, M2023 Q36-38 (≥8×)

Inconduite scientifique (FFP) — fabrication vs falsification vs plagiat :

- FABRICATION = création de données NON RÉELLES (inventées)
- FALSIFICATION = MANIPULATION / altération de données réelles
- PLAGIAT = utilisation non autorisée des idées d'autrui sans citation
- Δ Ne pas confondre fabrication (inventer) et falsification (manipuler) — piège systématique

□ Vu : R2025 Q17, Jun2024 Q46, Jul2024 Q46, M2021 Q49, M2020 Q41 (≥6×)

Le consentement VALIDE du participant — ses composantes :

- Volontariat (liberté de choix) + Information adéquate + Compréhension + Prise de décision
- Le formulaire doit mentionner : objet, bénéfices potentiels, risques potentiels
- Δ La CONFIDENTIALITÉ n'est PAS un critère de validité du consentement
- Δ Une INDEMNITÉ / rémunération importante n'est PAS un critère (= risque d'incitation excessive)
- Δ La liste des auteurs ne figure PAS dans le formulaire de consentement

□ Vu : M2022 Q43, M2021 Q47, M2020 Q45-47, N2025 Q12 (≥6×)

Validité scientifique vs Valeur sociale :

- Validité scientifique = MÉTHODOLOGIE de recherche RIGOUREUSE
- Valeur sociale = amélioration de l'état de santé / bénéfice pour la société
- Δ « validité scientifique = sélection équitable » → FAUX (c'est la justice)
- Δ « validité scientifique = amélioration de la santé » → FAUX (c'est la valeur sociale)

□ Vu : R2025 Q13, Jun2024 Q41, Jul2024 Q41, M2022 Q42, M2020 Q49 (≥7×)

Authorship (qualité d'auteur) — conduite responsable :

- Implique d'ACCORDER LE MÉRITE approprié aux chercheurs ayant contribué
- Δ L'inclusion non justifiée d'un nom = « gift authorship » = fautive
- Δ Authorship ≠ prévention des conflits d'intérêts, ≠ évaluation par les pairs

□ Vu : M2023 Q31, M2022 Q44 (2×)

Recherche internationale, exploitation & études scandaleuses :

- Recherche internationale = menée dans les pays en développement, FINANCÉE par les pays développés
- Exploitation des populations pauvres → principe de JUSTICE compromis
- Standard universel = meilleur traitement disponible offert au groupe contrôle
- ⚠ Essai AZT (transmission VIH mère-enfant) → problème = USAGE DU PLACEBO dans le groupe contrôle
- ⚠ Tuskegee (syphilis) → RESPECT DES PERSONNES violé ; Antonio Benino (fièvre jaune) → VOLONTARIAT violé
- ⚠ Personnes vulnérables : autonomie compromise mais PEUVENT participer SOUS conditions (non exclues)

□ Vu : R2025 Q14-15, Jun2024 Q42-43, M2020 Q50, M2023 Q40 (≥9×)

[RANG 2] RISQUE PROFESSIONNEL EN MILIEU DE SOINS

— • ~3.15 Q/examen

□ Source : med-travail-aio.pdf — Médecine du travail FMPM

Classification des risques professionnels (le cœur du chapitre — à maîtriser absolument) :

- ORGANISATION du travail → risque ERGONOMIQUE, risque PSYCHOSOCIAL, travail répétitif
- ENVIRONNEMENT du travail → risque CHIMIQUE, PHYSIQUE (bruit, chaleur, froid), BIOLOGIQUE (virus/bactéries/parasites)
- SÉCURITÉ → chute de plain-pied, INCENDIE, ÉLECTRISATION, AES, violence
- ⚠ Chaleur/bruit = ENVIRONNEMENT, PAS sécurité ; chute/incendie = SÉCURITÉ, PAS environnement
- ⚠ Risque ergonomique & psychosocial = ORGANISATION, jamais environnement

□ Vu : R2025 Q32-35, N2025 Q29-35, Jun2024 Q27-29, Jul2024 Q27-29 (≥15×)

Hierarchie des moyens de prévention :

- Le PLUS performant = SUPPRIMER le danger (action à la source)
- Bases de la prévention : moyens techniques + organisationnels + comportement/formation + surveillance médicale
- ⚠ Le moyen le MOINS adapté = AFFICHER le danger
- ⚠ Le « fatalisme » et « l'assurance maladie » ne sont JAMAIS des bases de prévention

□ Vu : R2025, Jun2024 Q23-24/30, Jul2024 Q23-24/30, N2025 Q30 (≥8×)

Ergonomie & nature de la médecine du travail :

- Ergonomie = adapter le POSTE de travail aux caractéristiques PHYSIOLOGIQUES et PSYCHOLOGIQUES du travailleur
- Médecine du travail au Maroc = discipline médicale ESSENTIELLEMENT PRÉVENTIVE
- ⚠ « Adapter le travailleur au poste » → FAUX (c'est l'inverse : le poste au travailleur)

□ Vu : Jun2024 Q25, Jul2024 Q22/25, M2023 (≥4×)

Cancer professionnel & couverture de l'étudiant :

- Cancer professionnel le plus fréquent = cancer BRONCHO-PULMONAIRE
- L'étudiant en médecine est couvert (AT) pendant le STAGE HOSPITALIER
- ⚠ Si le cancer broncho-pulmonaire n'est pas proposé → « aucune réponse juste » (piège M2021 Q25)

□ Vu : R2025 Q31, M2021 Q25, M2020 Q6 (3×)

[RANG 3] INTRODUCTION ET PRINCIPES DE L'ÉTHIQUE

— • ~3.00 Q/examen

□ Source : ethique-aio.pdf — Éthique & Déontologie FMPM

Les 4 principes de l'éthique médicale :

- BIENFAISANCE — NON-MALFAISANCE — RESPECT DE LA PERSONNE (autonomie) — JUSTICE
- ⚠ La DÉONTOLOGIE n'est PAS un principe de l'éthique ; le PATERNALISME non plus
- ⚠ Piège : on liste souvent 3 bonnes réponses parmi 5 — éliminer déontologie & paternalisme

□ Vu : R2025 Q2, M2023 Q42 (≥4×)

Éthique déontologique (kantienne) vs utilitariste (conséquentialiste) :

- Déontologique = KANTIENNE = centrée sur les DEVOIRS / la morale / les droits
- Utilitariste = conséquentialiste = basée sur les CONSÉQUENCES / résultats attendus
- ⚠ « kantienne = conséquentialiste » → FAUX ; ce sont deux courants opposés

□ Vu : R2025 Q1, N2025 Q7, Jun2024 Q33, M2021 Q31, M2023 Q41 (≥6×)

Contenu de chaque principe :

- Bienfaisance = l'acte doit avoir un EFFET BÉNÉFIQUE pour le patient
- Non-malfaisance = ne pas nuire (au patient ET à l'entourage) ; bénéfice > effet nocif ; arrêter un traitement plus nocif qu'utile
- Respect de la personne = consentement préalable + participation à la décision + confidentialité
- ⚠ Un acte n'est entrepris que si le BÉNÉFICE est SUPÉRIEUR à l'effet nocif (pas égal)

□ Vu : Jun2024 Q34-35, M2021 Q39-40, Nov2024 Q9-10 (≥8×)

Autonomie & consentement éclairé :

- Patient autonome : comprend l'information, donne un consentement éclairé, PEUT REFUSER les soins
- Consentement = accord AVANT tout acte + compréhension PAR LE PATIENT + participation à la décision
- ⚠ « le patient doit suivre toutes les décisions sans hésiter » → FAUX (= paternalisme)
- ⚠ « compréhension de l'information par le MÉDECIN » → FAUX (c'est par le PATIENT)

□ Vu : M2021 Q38, M2023 Q43, M2020 Q38, Nov2024 Q8 (≥6×)

Exceptions au secret professionnel / à la confidentialité :

- Enseignement aux étudiants, intervention d'un interprète, maladies à déclaration obligatoire (MDO), implication de l'entourage dans la PEC, pathologies contagieuses
- ⚠ « maladie grave / de mauvais pronostic » seule n'est PAS une exception au secret

□ Vu : M2023 Q44, M2022 Q33 (2×)

Conflit de principes & dignité :

- Patient refusant une chirurgie indiquée → conflit RESPECT DE LA PERSONNE ↔ BIENFAISANCE
- Dignité capitale : incapables de décision, prélèvement d'organe, soins de fin de vie
- Qualités du médecin : écoute, empathie, honnêteté, intégrité, professionnalisme
- ⚠ Paternalisme (rôle directeur, décider à la place du patient) = contraire au respect de l'autonomie

□ Vu : M2022 Q32, M2021 Q34, M2020 Q37 (≥4×)

[RANG 4] FORME MÉDICO-LÉGALE DE LA MORT : CERTIFICAT DE DÉCÈS

— • ~2.77 Q/examen

□ Source : med-legal-aio.pdf — Médecine légale FMPM

Structure du bulletin de décès — les deux parties (très piégé) :

- Partie SUPÉRIEURE (nominative) : identité, adresse, profession → destinée à l'ÉTAT CIVIL, remise à la famille, porte la mention obstacle médico-légal (oui/non)
- Partie INFÉRIEURE (anonyme) : confidentielle → STATISTIQUES du ministère de la Santé ; causes médicales (Partie I = chaîne causale, Partie II = états contributifs) ; recherche grossesse si femme
- ⚠ La partie supérieure N'est PAS destinée aux statistiques et NE contient PAS la cause de la mort

- **⚠ Volet médical (Partie I) : a) cause immédiate → b) → c) cause initiale**

□ Vu : R2025 Q37, Jun2024 Q5, M2020 Q20, M2017 Q8, M2022 Q9-10 (≥8×)

Mort médico-légale (= obstacle médico-légal) — les situations :

- Mort violente/suspecte/de cause inconnue, TIAC, mort subite/brutale, complication d'un acte de soin, décès lié à un traumatisme même différé
- **⚠ Le cas « chute au hammam → HSD opéré → décès » = MORT MÉDICO-LÉGALE (lien possible traumatisme-décès)**
- **⚠ Mesure INAPPROPRIÉE : remettre à la famille un certificat attestant la CAUSE de la mort**

□ Vu : Jun2024 Q3-4, Jul2024 Q3-4/15, M2018 Q8 (≥8×)

Critères de SUSPICION et formes particulières :

- L'élément qui rend une mort suspecte = la CAUSE INCONNUE du décès
- Coexistence cause naturelle (athérome) + traumatisme (fracture cartilage thyroïde) → forme INDÉTERMINÉE
- **⚠ L'ÂGE AVANCÉ n'est PAS un critère de suspicion (piège M2018 Q9)**
- **⚠ Phosphore d'aluminium / odeur de poisson pourri → forme SUICIDAIRE (toxique classique au Maroc)**

□ Vu : Jun2024 Q13, M2020 Q29-30, M2019 Q8, M2016 Q5-6, Jul2024 Q14 (≥9×)

Crime maquillé en suicide & effet juridique :

- Arguments de crime : deux sillons cervicaux, traumatisme crânien associé, plaie thoracique POSTÉRIEURE, lividités non concordantes
- Coup mortel par un mineur → « coups et blessures ayant entraîné la mort SANS intention de la donner »
- **⚠ Plaie de coupure à la face antérieure du poignet / plaie précordiale = compatibles avec un SUICIDE (pas un argument de crime)**
- **⚠ Le statut de mineur n'exonère PAS de la responsabilité pénale**

□ Vu : M2018 Q14, M2019 Q11, M2017 Q10 (≥3×)

[RANG 5] RESPONSABILITÉ MÉDICALE

— • ~2.31 Q/examen

□ Source : med-legal-aio.pdf — Médecine légale FMPM

Les quatre types de responsabilité — la grande matrice :

- PÉNALE → but = SANCTION ; code pénal ; même pour faute INVOLONTAIRE ; peut interdire l'exercice
- CIVILE → but = RÉPARATION/indemnisation ; obligation de MOYENS (parfois de RÉSULTAT) ; obligation de sécurité du matériel
- ORDINALE/disciplinaire → but = sanction déontologique ; Conseil RÉGIONAL de l'Ordre statue en 1ère instance
- ADMINISTRATIVE → médecin fonctionnaire (public) → tribunal administratif
- **⚠ La responsabilité PÉNALE ne nécessite PAS forcément un dommage physique (piège récurrent)**
- **⚠ La responsabilité CIVILE n'expose PAS à l'emprisonnement (c'est le pénal)**
- **⚠ L'ordinaire NE fait PAS indemniser le patient ; l'AMENDE n'est PAS une sanction ordinale**

□ Vu : M2018 Q22-24, M2017 Q22/25, M2016 Q23-24, M2020 Q26-27, N2025 Q42 (≥12×)

Cumul des responsabilités & juridiction compétente :

- Médecin du PRIVÉ, faute involontaire avec dommage → PÉNALE + CIVILE + ORDINALE
- Demande de réparation (privé) → tribunal CIVIL ; secteur public → tribunal administratif
- **⚠ Refus de se déplacer en urgence → décès = Conseil Régional de l'Ordre (+ pénal pour non-assistance)**
- **⚠ Publication Facebook diffamatoire : civile + pénale + ordinale + disciplinaire — MAIS PAS tribunal administratif**

□ Vu : N2025 Q42, M2022 Q13, M2017 Q24, M2016 Q21, M2019 Q25 (≥6×)

La faute médicale & l'acte médico-légal :

- Faute = manquement à un devoir préexistant ; nécessite un LIEN DE CAUSALITÉ avec le préjudice pour indemniser ; peut être un défaut d'information
- Un acte ML peut MATÉRIALISER une infraction et établir un lien de causalité ; éléments de l'infraction = LÉGAL + MATÉRIEL + MORAL
- *⚠ La faute n'a PAS besoin d'être « grave » pour engager la responsabilité (une faute simple suffit)*
- *⚠ Le médecin NE QUALIFIE PAS juridiquement l'infraction (rôle du juge) — il constate et décrit*

□ Vu : M2016 Q25, N2025 Q36/41, M2018 Q1 (≥5×)

Activités médico-légales & droit à la vie :

- Civil : filiation, mise sous tutelle, dommage corporel (AVP) ; Pénal : âge de l'auteur, aptitude à la garde à vue, agression sexuelle
- Pour éviter les poursuites : suivre les recommandations des sociétés savantes
- *⚠ Mission ÉTHIQUEMENT INACCEPTABLE pour le légiste : test de virginité (atteinte à la dignité)*
- *⚠ Au nom du droit à la vie : on PEUT hospitaliser sous contrainte un patient suicidaire (pas d'acharnement obligatoire)*

□ Vu : R2025 Q38, M2023 Q1, M2022 Q15, M2016 Q1-2 (≥6×)

[RANG 6] PHÉNOMÈNES CADAVÉRIQUES ET DATATION

— • ~2.23 Q/examen

□ Source : med-legal-aio.pdf — Médecine légale FMPM

Datation par la température (Vibert / abaque de Henssge) :

- Règle pratique à la phase moyenne : délai $\approx (37 - T^{\circ} \text{ rectale})$ heures ($\sim 1^{\circ} \text{C/h}$ après plateau)
- Exemples : T 33 °C → ~8 h ; T 31 °C → 6-12 h ; T 28 °C → 12-24 h
- *⚠ La courbe de refroidissement n'est PAS linéaire (sigmoïde, plateau initial ~3 h)*

□ Vu : R2025 Q40, Jun2024 Q2/12, M2022 Q8, M2020 Q28, M2016 Q4 (≥8×)

Refroidissement, lividités, rigidité — les pièges :

- Refroidissement ACCÉLÉRÉ par les courants d'air, RALENTI si corpulent ; plus marqué en surface
- Lividités : zones DÉCLIVES, mobiles si position changée AVANT 12 h, fixées après ; couleur orientée (rose vif = CO/froid)
- Rigidité : s'installe de HAUT en BAS ; touche muscles striés et lisses
- *⚠ Lividités « aux zones d'appui » → FAUX (zones déclives) ; « apparaissent à 24 h » → FAUX (2-3 h)*

□ Vu : Jun2024 Q1/10, M2019 Q4-6, M2018 Q6 (≥8×)

Putréfaction, identification & cadre de la médecine légale :

- Putréfaction favorisée par bactéries/champignons ; RALENTIE par l'adipocire (saponification)
- ADN : filiation, salive, bulbe pileux, catastrophe de masse — mais PAS la détermination de l'âge
- Médecine légale = spécialité à part entière, non curative, saisie en civil ET pénal (loi 77-17)
- *⚠ La QUALIFICATION des faits (agression sexuelle, coups volontaires) relève du JUGE, pas du médecin*

□ Vu : M2018 Q7, M2016 Q7, M2020 Q16-17, M2019 Q1, M2022 Q1 (≥6×)

[RANG 7] LEVÉE DU CORPS ET AUTOPSIE

— • ~2.15 Q/examen

□ Source : med-legal-aio.pdf — Médecine légale FMPM

La levée du corps :

- = examen EXTERNE du cadavre SUR LES LIEUX ; régie par le Code de procédure pénale ; sur RÉQUISITION ÉCRITE du parquet
- Renseignements : ancienneté de la mort, âge, sexe, déplacement secondaire, agent vulnérant

- Conduite finale : rapport ML + bulletin AVEC obstacle ML + transfert au service de ML
- *⚠ Jamais sur demande ORALE ; le médecin ne peut refuser une réquisition*
- *⚠ Ne renseigne PAS sur les blessures VISCÉRALES (→ autopsie) ni le propriétaire de l'arme*

□ Vu : R2025 Q39, N2025 Q37-39, M2021 Q3, M2018 Q10, M2022 Q2-3 (≥8×)

Autopsie JUDICIAIRE vs SCIENTIFIQUE :

- Judiciaire : ordonnée par le PARQUET / juge d'instruction ; cadavre = PIÈCE À CONVICTION ; complète ; non refusable par la famille
- Scientifique : demandée par le médecin traitant ; PEUT être refusée par la famille ; vise la cause médicale
- *⚠ L'autopsie judiciaire n'est PAS « à des fins scientifiques » et n'a PAS pour but l'identification si le corps est déjà identifié*
- *⚠ Le défunt NE peut PAS s'y opposer de son vivant ; ni la famille, ni le directeur d'hôpital ne l'ordonnent*

□ Vu : Jun2024 Q6, Jul2024 Q6, M2021 Q4, M2016 Q8, Nov2024 Q38 (≥7×)

Forme ML selon le constat autopsique :

- Hémopéricarde par rupture du VG (post-IDM) → NATURELLE
- Embolie pulmonaire après chute/alitement → lien causal PROBABLE avec la chute (indemnisation possible)
- *⚠ Pendaison : possible même si les pieds touchent le sol (pendaison incomplète)*
- *⚠ Examen du gardé à vue = situation idéale pour contrôler le respect de l'interdiction de la torture*

□ Vu : M2019 Q9, Jun2024 Q7, M2018 Q13, M2020 Q19 (≥5×)

[RANG 8] ÉTHIQUE ET SANTÉ PUBLIQUE

— • ~1.92 Q/examen

□ Source : éthique-aio.pdf — Éthique & Déontologie FMPM

Les deux principes structurants de l'éthique de santé publique :

- Principe DÉONTOLOGIQUE = JUSTICE DISTRIBUTIVE (répartition équitable des ressources)
- Principe CONSÉQUENTIALISTE = l'UTILITÉ (maximiser le bien-être collectif)
- Focus : perspective COMMUNAUTAIRE, déterminants sociaux, distribution des ressources
- *⚠ L'éthique de santé publique NE se centre PAS sur l'individu ni l'autonomie individuelle (≠ éthique clinique)*

□ Vu : R2025 Q18-19, N2025 Q17/19, Jun2024 Q48, M2022 Q46-47 (≥8×)

Les mesures de santé publique = approche utilitariste :

- Confinement COVID, vaccination des enfants / PNI, déclaration obligatoire des maladies (MDO)
- = approche UTILITARISTE / conséquentialiste visant à protéger le bien-être de la COMMUNAUTÉ
- Triage en réanimation (ventilateurs limités) = éthique utilitariste
- *⚠ Isolement obligatoire des cas → conflit NON-MALFAISANCE ↔ RESPECT DE LA PERSONNE*
- *⚠ Ces mesures ne « respectent » PAS la liberté individuelle — elles la restreignent au profit du collectif*

□ Vu : M2021 Q41, Jun2024 Q47, M2020 Q33/39/42, M2023 Q32 (≥9×)

[RANG 9] RÉPARATION DES MALADIES PROFESSIONNELLES + ACCIDENTS DU TRAVAIL

— • ~1.69 Q/examen

□ Source : med-travail-aio.pdf — Médecine du travail FMPM

Accident du travail (AT) vs maladie professionnelle (MP) :

- AT = action SOUDAIN et violente + lien avec le travail + lésion physique OU psychologique ; déclaré par l'EMPLOYEUR sous 48 h
- MP indemnisable = figure dans un TABLEAU + CMI + délai de prise en charge respecté → indemnisation QUASI-AUTOMATIQUE ; déclarée par le SALARIÉ
- ⚠ MP = installation PROGRESSIVE (s'oppose à l'AT soudain)
- ⚠ Maladie à CARACTÈRE professionnel : NE figure PAS dans un tableau, PAS d'indemnisation automatique

□ Vu : R2025 Q26/33, N2025 Q28, M2022 Q16/28, M2023 Q19-20 (≥8×)

Le tableau de réparation & le délai de prise en charge :

- Tableau = numéro + titre + délai de prise en charge + colonne maladies + liste indicative OU limitative des travaux à risque
- Délai de prise en charge = délai pour demander réparation APRÈS l'arrêt de l'exposition
- ⚠ Le délai n'est défini ni par le médecin traitant, ni par le médecin du travail, ni par le juge
- ⚠ L'incapacité permanente ne figure PAS dans la composition du tableau

□ Vu : M2022 Q18-19, M2021 Q19-20, M2020 Q8/14, N2025 Q23 (≥8×)

Intérêts de la déclaration & diagnostic :

- Intérêts : soins de la victime, indemnisation, amélioration de la prévention, données épidémiologiques
- Diagnostic d'une maladie à caractère professionnel = avis du médecin du travail OU du médecin traitant
- ⚠ « garder son poste à vie » n'est PAS un intérêt de la déclaration

□ Vu : N2025 Q27, M2023 Q23/25, M2020 Q15 (≥5×)

[RANG 10] CODE DE DÉONTOLOGIE

— • ~1.46 Q/examen

□ Source : éthique-aio.pdf — Éthique & Déontologie FMPM

Devoirs du médecin envers le patient :

- Attitude professionnelle exemplaire, secret professionnel, honnêteté, soins de qualité, soins d'urgence = devoir
- Ne pas laisser le profit influencer le jugement professionnel
- ⚠ Certifier seulement ce qu'il a PERSONNELLEMENT vérifié (pas ce qu'un confrère a vérifié)

□ Vu : R2025 Q4, N2025 Q5, Jun2024 Q36, M2021 Q32 (≥6×)

Interdits déontologiques :

- Recevoir/verser une COMMISSION pour adresser un patient (dichotomie), ATTIRER les patients des confrères, PUBLICITÉ sur les réseaux sociaux, utiliser un ALIAS, certifier ce qu'on n'a pas vérifié
- ⚠ Participer à des campagnes d'information/promotion de la santé est AUTORISÉ (pas un interdit)

□ Vu : R2025 Q5, N2025 Q4, Jun2024 Q37, M2023 Q46, M2021 Q33 (≥8×)

Buts & portée du code :

- Définit les devoirs du médecin envers patients, confrères et la communauté ; établit les normes de l'exercice
- ⚠ Le code NE résout PAS les conflits entre principes éthiques (rôle de l'éthique, pas de la déontologie)

□ Vu : M2023 Q45, M2020 Q34 (2×)

[RANG 11] AGRESSIONS SEXUELLES

— • ~1.46 Q/examen

□ Source : med-legal-aio.pdf — Médecine légale FMPM

Conduite à tenir devant une victime d'agression sexuelle :

- Cadre calme et isolé, hors urgences ; éliminer une détresse vitale ; CONSENTEMENT de la victime ; expliquer le déroulement ; présence d'une femme souhaitable
- Soins en premier → prélèvements ML (jamais remis à la victime/famille) → certificat avec ITP
- Mesures associées : contraception d'urgence, prophylaxie VIH/IST, vaccination HVB, soutien psychologique, sérologies
- *⚠ L'examen génital sur réquisition exige tout de même le consentement*
- *⚠ Les prélèvements NE sont JAMAIS remis à la victime/famille ; ne pas les détruire en cas de refus de plainte (conservation)*

□ Vu : R2025 Q42, N2025 Q43-44, M2023 Q7, M2022 Q11-12, M2021 Q15 (≥9×)

Sperme, hymen & contraception d'urgence — pièges médico-légaux :

- PSA/sperme : identification de l'auteur, positif jusqu'à ~3 jours, congeler si examen différé
- Contraception d'urgence : retarde/inhibe l'ovulation, non abortive, possible chez une mineure, pas de bilan préalable nécessaire
- *⚠ Sperme intravaginal chez une adulte ≠ preuve de VIOL (le viol est une qualification juridique, pas médicale)*
- *⚠ Un hymen intact n'écarte PAS une agression ; l'examen de l'hymen a peu de valeur en cas d'agression ANCIENNE chez une pubère*
- *⚠ La contraception d'urgence NE protège PAS contre les IST*

□ Vu : M2019 Q17-18, M2020 Q24, M2018 Q17, M2016 Q16-17 (≥7×)

[RANG 12] JUSTICE ET ÉQUITÉ

— • ~1.38 Q/examen

□ Source : éthique-aio.pdf — Éthique & Déontologie FMPM

Équité vs égalité & système de soins équitable :

- Équité = conception DIFFÉRENTIALISTE de la justice : prend en compte les différences, peut impliquer un traitement DIFFÉRENT pour une égalité EFFECTIVE
- Système équitable : solidarité malades/non-malades + mutualisation des risques + couverture PROPORTIONNELLE aux besoins
- *⚠ Équité ≠ traitement identique de tous ; ≠ contribution/distribution ÉGALE*

□ Vu : R2025 Q20, N2025 Q18, Jun2024 Q49, M2023 Q33, M2022 Q48 (≥8×)

Discrimination positive & systèmes de financement :

- Discrimination positive = conception RÉPARATRICE/différentialiste : compensation des préjudices/handicaps, attribution préférentielle
- Système nationalisé/étatique = BEVERIDGIEN (vs bismarckien = assurantiel)
- *⚠ Discrimination positive ≠ traitement identique de tous*

□ Vu : M2023 Q34, M2022 Q49, M2021 Q42/44, M2020 Q43, Jun2024 Q50 (≥7×)

[RANG 13] PRÉLÈVEMENT ET TRANSPLANTATION D'ORGANE (loi 16-98)

— • ~1.38 Q/examen

□ Source : med-legal-aio.pdf — Médecine légale FMPM

Diagnostic de la mort encéphalique :

- Coma profond flasque aréactif + ABSENCE de ventilation spontanée (épreuve d'hypercapnie) + angioscanner = défaut de perfusion cérébrale
- Nécessite une assistance respiratoire totale ; des réflexes d'origine MÉDULLAIRE peuvent persister ; diurèse possible

- **⚠ La mort est déclarée dès que la MORT ENCÉPHALIQUE est constatée (pas « mort de toutes les cellules »)**
- **⚠ Les médecins qui constatent la mort encéphalique NE doivent PAS faire partie de l'équipe de prélèvement**

□ Vu : M2023 Q8, M2019 Q2-3, M2018 Q3, M2017 Q3, M2016 Q3 (≥7×)

Consentement & règles du prélèvement (loi 16-98) :

- Donneur VIVANT : possible pour un proche/parent (consentement devant magistrat) ; ex : rein, moelle osseuse (mineur autorisé pour un proche)
- Donneur DÉCÉDÉ : consentement présumé (absence de refus exprimé du vivant) ; transplantation en établissement PUBLIC agréé ; anonyme et gratuit
- **⚠ Prélèvement interdit en clinique privée pour le don cadavérique (M2018 Q5)**
- **⚠ Démarche ML sur sujet en mort encéphalique : chercher un refus exprimé du vivant + informer la famille/conjoint**

□ Vu : Jun2024 Q9, M2019 Q21-22, M2018 Q4-5, M2016 Q19 (≥7×)

Contre-indications au prélèvement :

- Le carcinome BASO-cellulaire localisé n'est PAS une contre-indication (tumeur non métastatique)
- **⚠ CI : septicémie cause du décès, hépatite C chronique, toxicomanie dure, néoplasie maligne, HTA sévère (vivant)**

□ Vu : M2017 Q23, M2016 Q20 (2×)

[RANG 14] BLESSURE (traumatologie médico-légale)

— • ~1.31 Q/examen

□ Source : med-legal-aio.pdf — Médecine légale FMPM

Contusions, ecchymoses & abrasions :

- Ecchymose = contusion du 1er degré, lésion VITALE (anté-mortem) ; évolution chromatique, disparition en ~20-25 jours
- Abrasions : renseignent sur le sens de friction, l'agent, le caractère anté/post-mortem (parcheminement)
- **⚠ Les ecchymoses ne se produisent PAS après la mort (lésions vitales)**
- **⚠ Ecchymose verdâtre = plus ANCIENNE que violacée (chronologie chromatique)**

□ Vu : R2025 Q49, M2021 Q8, M2020 Q21, M2019 Q12 (≥5×)

Plaies par armes & plaies par arme à feu :

- Plaie par enfoncement : renseigne sur la longueur du manche/lame ; orifice d'entrée = collerette érosive/d'essuyage
- Distinguer entrée/sortie : tatouage & enfumage (tirs rapprochés), collerette, chambre de mine (bout touchant)
- **⚠ Le diamètre de l'orifice d'entrée n'est PAS toujours plus petit (M2017 Q14)**
- **⚠ Tatouage à >3 m → FAUX (le tatouage = tir à distance intermédiaire/rapprochée)**
- **⚠ CBV qualifiés selon CONSÉQUENCES/circonstances/qualité de la victime — le seuil d'ITP est de 21 jours**

□ Vu : M2017 Q13-14, M2016 Q9-10, M2019 Q13, M2018 Q11/19 (≥7×)

[RANG 15] SÉVICES À ENFANT + INFANTICIDE

— • ~1.23 Q/examen

□ Source : med-legal-aio.pdf — Médecine légale FMPM

Signalement & prise en charge de la maltraitance :

- Signalement OBLIGATOIRE au Procureur du Roi (article 446 du code pénal lève le secret) ; hospitaliser + protéger ; avertir l'assistante sociale
- Faveur de maltraitance : lésions de violence multiples d'âges différents, séquelles anciennes (cals, cicatrices), incohérence du récit, contexte de vulnérabilité
- Certificat ML avec ITP ; intérêt à défendre EN PREMIER = celui de l'ENFANT
- **⚠ Le consentement des parents n'est PAS requis pour signaler (signalement même malgré leur refus)**
- **⚠ La maltraitance peut être qualifiée de CRIME (ex : perte d'un œil → infirmité permanente)**

□ Vu : R2025 Q47, Nov2024 Q47-48, M2023 Q14, M2022 Q6-7, M2021 Q9/13-14 (≥9×)

Infanticide & éthique de l'enfant maltraité :

- Infanticide = décès d'un nourrisson < 1 an ; la mère bénéficie d'une dérogation de peine ; le médecin détermine terme/délai post-mortem/cause
- Éthique : chercher la solution la moins nuisible, associer l'enfant aux décisions, ne pas le remettre aux parents maltraitants si grave
- **⚠ NE PAS privilégier l'intérêt de « toute la famille » sur celui de l'enfant seul (M2018 Q16)**
- **⚠ La maltraitance n'est PAS justifiée par le caractère turbulent de l'enfant**

□ Vu : R2025 Q44, M2020 Q22-23, M2019 Q16, M2018 Q15-16, M2017 Q1 (≥7×)

[RANG 16] RÔLES ET MISSIONS DU MÉDECIN DU TRAVAIL

— • ~1.15 Q/examen

□ Source : med-travail-aio.pdf — Médecine du travail FMPM

Nature & rôles :

- Discipline ESSENTIELLEMENT PRÉVENTIVE ; préserve la santé PHYSIQUE et MENTALE ; rôles technique, gestionnaire, conseiller, urgences
- Statut sur l'APTITUDE au poste ; surveille la santé ET le milieu de travail ; prend en charge TOUS les travailleurs
- **⚠ Ne PRESCRIT PAS de traitements courants en dehors des urgences (pas de rôle curatif de soins)**

□ Vu : R2025 Q28, N2025 Q21, Jun2024 Q22, M2021 Q21, M2020 Q12 (≥7×)

Visites médicales :

- Embauche (aptitude/inaptitude + examens si besoin), périodique/systématique, surveillance médicale renforcée (SMR), reprise, à la demande
- Reprise OBLIGATOIRE après : MP, AT, absences répétées, absence santé > 3 semaines
- **⚠ « absence de plus de 2 semaines » → FAUX (le seuil officiel est de 3 semaines / 21 jours)**
- **⚠ Étudiant couvert AT : stages hospitaliers + travaux pratiques**

□ Vu : N2025 Q22, Nov2024 Q25, M2022 Q25-26, M2021 Q22 (≥6×)

[RANG 17] CERTIFICATS MÉDICAUX

— • ~1.08 Q/examen

□ Source : med-legal-aio.pdf — Médecine légale FMPM

Certificats médicaux & certificat médico-légal :

- Écrits OFFICIELS constatant/interprétant un fait médical ; engagent la responsabilité PÉNALE et ORDINALE
- CML : descriptif/positif, identité du rédacteur, papier en-tête, âge de la victime, 2 exemplaires, ITP/ITT ; peut être rédigé par un interne
- Bonnes pratiques : mentionner date/heure, remettre une copie au patient, ne pas divulguer la vie privée
- **⚠ Le CML NE qualifie PAS juridiquement l'infraction (rôle du juge)**
- **⚠ Date du certificat de coups et blessures = date de RÉDACTION (pas de l'agression) ; peut être rédigé à distance**

□ Vu : R2025 Q45, N2025 Q40/45, M2023 Q15, M2019 Q19, M2016 Q18 (≥7×)

Cadre légal, ITP & employeur :

- ITP : dépend du retentissement FONCTIONNEL ; différencie contravention/délit/crime ; seuil de 21 jours
- Certificat de repos : contrôlé par l'organisme régulateur, ≤ 6 mois consécutifs
- ⚠ *Certificats SANS obligation légale : certificat de VIRGINITÉ, non-contre-indication au sport*
- ⚠ *L'employeur ne peut PAS recevoir un certificat détaillant les blessures d'un AT (confidentiel)*
- ⚠ *Fraude à la feuille de soins (faux) → responsabilité ORDINALE + PÉNALE (correctionnelle)*

□ Vu : M2018 Q20-21, M2019 Q20, M2017 Q21, R2025 Q46, Jun2024 Q11 (≥7×)

[RANG 18] ASPHYXIES MÉCANIQUES

— • ~1.08 Q/examen

□ Source : med-legal-aio.pdf — Médecine légale FMPM

Strangulation manuelle vs au lien ; pendaison :

- Strangulation manuelle : signes asphyxiques MARQUÉS, signes cervicaux RICHES (ecchymoses, fracture os hyoïde/cartilage thyroïde), crimes passionnels
- Pendaison : mode de suicide TRÈS fréquent, possible pieds au sol ; toujours évoquer un crime maquillé
- ⚠ *« signes autopsiques cervicaux pauvres dans la strangulation manuelle » → FAUX (ils sont riches)*
- ⚠ *Cas type (sillon horizontal + pétéchies + fracture os hyoïde) = STRANGULATION*

□ Vu : R2025 Q50, M2019 Q15, M2017 Q15, M2021 Q1, M2016 Q11 (≥6×)

Suffocation, noyade & syndrome asphyxique :

- Suffocation par obstruction des VAE : souvent criminelle, fréquente dans l'infanticide, possible accidentelle/suicidaire (sac plastique : signes asphyxiques rares)
- Submersion-inhibition : noyé BLANC, absence d'eau dans l'arbre trachéo-bronchique
- ⚠ *Le syndrome asphyxique n'est NI spécifique NI constant d'une asphyxie mécanique*
- ⚠ *« la suffocation ne peut survenir par accident » → FAUX (elle le peut)*

□ Vu : Jun2024 Q8, M2019 Q14, M2018 Q12, M2017 Q16-17 (≥6×)

[RANG 19] ÉTHIQUE ET FIN DE VIE

— • ~0.85 Q/examen

□ Source : ethique-aio.pdf — Éthique & Déontologie FMPM

Conduite & euthanasie passive vs active :

- Fin de vie : soins palliatifs + accompagnement + soulagement de la souffrance + dignité (mort dans la dignité = droit du patient)
- Euthanasie PASSIVE = arrêt des thérapeutiques qui prolongent la vie ; éthiquement plus acceptable ; relève de la non-malfaisance
- Euthanasie ACTIVE = administrer une substance létale ; suicide assisté = le patient la prend lui-même
- ⚠ *Pas d'ACHARNEMENT thérapeutique ni de traitements curatifs inefficaces*
- ⚠ *Ne pas confondre euthanasie passive (arrêt) et active (administration létale)*

□ Vu : R2025 Q8/10, N2025 Q1-2, Jun2024 Q38, M2022 Q35-36, M2021 Q35 (≥9×)

[RANG 20] ÉTHIQUE ET PROCRÉATION

— • ~0.77 Q/examen

□ Source : ethique-aio.pdf — Éthique & Déontologie FMPM

Statut de l'embryon & débat sur l'IVG :

- Embryon/fœtus = POTENTIELS êtres humains
- Débat IVG : conflit protection de la VIE ↔ CHOIX de la femme ; début de la vie non consensuel
- ⚠ *Embryon/fœtus ≠ « êtres humains », ≠ « personnes » (piège récurrent)*

□ Vu : R2025 Q6, Jun2024 Q40, M2023 Q47, M2022 Q38, N2025 Q9 (≥7×)

Problèmes éthiques de la PMA :

- Conservation des embryons/gamètes, choix du genre, DISSOCIATION des éléments de la procréation, devenir des embryons non implantés
- Dissociation = don/vente de gamètes + mères porteuses (GPA)
- ⚠ *Clonage reproductif = violation de la dignité + risque d'exploitation (prélèvement d'organes)*

□ Vu : R2025 Q7, N2025 Q10, M2022 Q39-40, M2023 Q48 (≥6×)

[RANG 21] DERMATOSES PROFESSIONNELLES

— • ~0.77 Q/examen

□ Source : med-travail-aio.pdf — Médecine du travail FMPM

Les deux principales dermatoses & diagnostic :

- Les 2 plus fréquentes d'origine chimique = dermatite d'IRRITATION + ECZÉMA de contact (allergique)
- Élément diagnostique clé = INTERROGATOIRE bien conduit (antécédents pro, conditions de travail, produits, protections)
- ⚠ *Irritative = atteinte COLLECTIVE, lésion localisée, tests cutanés NÉGATIFS ; allergique = individuelle, tests positifs*
- ⚠ *L'aptitude est déterminée par le MÉDECIN DU TRAVAIL ; la DP peut causer une perte d'emploi*

□ Vu : R2025 Q24, Jun2024 Q16-17, M2022 Q20, M2021 Q24, Nov2024 Q26-27 (≥7×)

[RANG 22] TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES (TMS)

— • ~0.77 Q/examen

□ Source : med-travail-aio.pdf — Médecine du travail FMPM

Définition, facteurs de risque & prévention :

- TMS = atteintes des MUSCLES, TENDONS, NERFS, vaisseaux — pathologies d'HYPER SOLlicitation, multifactorielles, évitables
- Facteurs biomécaniques : efforts/force élevée, répétitivité, postures contraignantes, manque de pause (+ stress, âge, sexe féminin)
- Prévention = responsabilité de TOUS (travailleur + médecin traitant + médecin du travail + employeur)
- ⚠ *Les TMS n'atteignent PAS l'OS (piège : os exclu, M2020 Q13 / M2021 Q27)*

□ Vu : R2025 Q25, Jun2024 Q20, M2023 Q27-28, M2022 Q30, M2021 Q27-28 (≥8×)

[RANG 23] ÉTHIQUE ET DON D'ORGANE

— • ~0.62 Q/examen

□ Source : ethique-aio.pdf — Éthique & Déontologie FMPM

Principes éthiques du don & problématiques du donneur vivant :

- GRATUITÉ (interdiction de commercialisation), VOLONTARIAT/altruisme, consentement préalable
- Donneur vivant : exposition d'une personne SAINTE aux risques, sentiment d'OBLIGATION familiale, donneur souvent pourvoyeur de la famille
- Donneur en mort cérébrale : problème = absence de consentement préalable + consentement du tuteur

- **⚠ « le donneur vivant est plus acceptable que le donneur en mort cérébrale » → FAUX (on privilégie l'inverse pour ne pas exposer un sujet sain)**
- **⚠ Aucune compensation financière du donneur**

□ Vu : R2025 Q9, N2025 Q3, Jun2024 Q39, M2023 Q50, M2021 Q36, M2022 Q37 (≥8×)

[RANG 24] PNEUMOPATHIES PROFESSIONNELLES (silicose, asthme)

— • ~0.62 Q/examen

□ Source : med-travail-aio.pdf — Médecine du travail FMPM

Silicose & asthme professionnel :

- Silicose = pneumoconiose FIBROGÈNE (silice), évolution LENTE, qui se poursuit après l'arrêt de l'exposition ; dépistage = RADIOGRAPHIE thoracique
- Asthme professionnel : tableau RYTHMÉ par le travail (aggravation au travail, amélioration aux congés) ; forme avec PÉRIODE DE LATENCE la plus fréquente
- **⚠ Silicose ≠ pneumoconiose de surcharge ; n'est PAS due à l'amiante**
- **⚠ Asthme : amélioration AU travail → faux indice (au contraire, aggravation au travail)**

□ Vu : R2025 Q21/27, Jun2024 Q18-19, Jul2024 Q18-19, Nov2024 Q21/30 (≥7×)

[RANG 25] ACCIDENT D'EXPOSITION AU SANG (AES)

— • ~0.62 Q/examen

□ Source : med-travail-aio.pdf — Médecine du travail FMPM

Définition & conduite à tenir immédiate :

- AES = contact avec du sang/liquide biologique (piqûre, coupure, projection muqueuse/peau lésée) ; géré comme un ACCIDENT DU TRAVAIL
- CAT : 1) arrêter le geste + sécuriser ; 2) nettoyer à l'eau et au savon ; 3) antisepsie ≥5 min (muqueuse → rinçage sérum physiologique 15 min) ; 4) évaluer le risque + sérologies source ; 5) déclarer (48 h) + médecin référent
- **⚠ Ne PAS faire saigner activement la plaie (item officiel) ; rôle du médecin référent = ÉVALUER le risque de contamination**

□ Vu : R2025 Q23, N2025 Q31, M2023 Q24, M2021 Q29-30, M2020 Q3/7 (≥8×)

Précautions universelles/standard :

- NE PAS recapuchonner les aiguilles, NE PAS les désadapter à la main, gants si lésion cutanée, couvrir les plaies, hygiène des mains avant/après
- **⚠ Recapuchonner ou désadapter à la main = faute de prévention**

□ Vu : R2025 Q23 (1×)

[RANG 26] RISQUES PSYCHOSOCIAUX (RPS)

— • ~0.62 Q/examen

□ Source : med-travail-aio.pdf — Médecine du travail FMPM

Facteurs vs conséquences des RPS :

- FACTEURS (causes) : intensité/temps de travail ÉLEVÉS, exigences ÉMOTIONNELLES élevées, MANQUE d'autonomie, rapports sociaux DÉGRADÉS, conflits de valeur, insécurité de l'emploi
- CONSÉQUENCES (troubles) : stress, anxio-dépression, burn-out/bore-out, troubles gastro-intestinaux, absentéisme, turn-over, grèves

- **⚠ Ne pas confondre FACTEURS (intensité, manque d'autonomie) et CONSÉQUENCES (burn-out, absentéisme)**
- **⚠ L'autonomie ÉLEVÉE et des rapports FAVORABLES sont PROTECTEURS (pas des facteurs de risque)**

□ Vu : Jun2024 Q21, M2023 Q29-30, M2022 Q27, M2021 Q26, M2020 Q11 (≥7×)

[RANG 27] SURDITÉ PROFESSIONNELLE

— • ~0.54 Q/examen

□ Source : med-travail-aio.pdf — Médecine du travail FMPM

Caractéristiques de la surdité au bruit :

- Surdité de PERCEPTION (atteinte cochléaire), BILATÉRALE et SYMÉTRIQUE, irréversible, NE s'aggrave PAS après l'arrêt de l'exposition ; comporte des stades cliniques
- Déficit minimal = 35 dB sur la meilleure oreille
- **⚠ Ce n'est PAS une surdité de transmission ; si le seuil de 35 dB n'est pas proposé (25/45/55) → « aucune réponse juste »**

□ Vu : R2025 Q29-30, M2022 Q29, M2021 Q23, M2020 Q1 (≥6×)

[RANG 28] CONSENTEMENT DU PATIENT

— • ~0.46 Q/examen

□ Source : éthique-aio.pdf — Éthique & Déontologie FMPM

Information & consentement :

- Information = condition du consentement ; porte sur diagnostic, options thérapeutiques, effets indésirables, conséquences du refus de soins
- Consentement RÉVOCABLE à tout moment ; refus documenté au dossier ; inscrit dans la loi (obligatoire)
- **⚠ Le consentement n'est PAS obligatoirement écrit (peut être oral) et n'est PAS facultatif**
- **⚠ Exceptions à l'information : urgence vitale, refus d'être informé, troubles psychotiques sévères — PAS le niveau d'instruction**
- **⚠ Défaut de consentement → responsabilité PÉNALE (prélèvement d'organe, expérimentation, PMA)**

□ Vu : N2025 Q47/50, M2023 Q11, M2021 Q11-12 (≥5×)

[RANG 29] QUESTIONS INCLASSIFIABLES (transversales)

— • ~0.31 Q/examen

□ Sources : eth./med-legal/med-travail-aio.pdf

Items transversaux récurrents :

- IVG : début de la vie non consensuel + embryon = potentiel être humain
- Cancer professionnel le plus fréquent = broncho-pulmonaire
- Droit International Humanitaire (DIH) : s'applique en temps de CONFLIT, protège civils + personnel médical, ne régit pas le jus ad bellum, restreint les armes
- **⚠ DIH : « protège le personnel médical en temps de PAIX » → FAUX (s'applique en temps de conflit)**

□ Vu : N2025 Q9, M2020 Q10, M2017 Q2 (≥3×)

[RANG 30] RADIOPROTECTION

— • ~0.31 Q/examen

□ Source : med-travail-aio.pdf — Médecine du travail FMPM

Principes & moyens :

- 3 principes (CIPR) : JUSTIFICATION, OPTIMISATION (ALARA), LIMITATION des doses
- Réduire l'exposition externe = règle TDS : réduire le TEMPS, augmenter la DISTANCE, utiliser des ÉCRANS/blindage
- Effets DÉTERMINISTES à forte dose (seuil) ; effets STOCHASTIQUES même à faible dose (sans seuil)
- ⚠ « s'approcher de la source pour mieux la contrôler » → FAUX (augmenter la distance)

□ Vu : N2025 Q24-26, M2023 Q22 (≥4×)

[RANG 31] ABSTENTION FAUTIVE (non-assistance)

— • ~0.31 Q/examen

□ Source : med-legal-aio.pdf — Médecine légale FMPM

Réalité du péril & sanctions :

- Abstention fautive : péril ACTUEL ; le bénéficiaire peut être vieillard/mourant/nouveau-né (peu importe la viabilité s'il est vivant) ; péril traumatique ou pathologique
- Refus de déplacement en urgence → décès = Conseil Régional de l'Ordre + tribunal de 1ère instance (pénal)
- ⚠ Sanctions ordinaires : avertissement, blâme, suspension (à temps), RADIATION — PAS d'AMENDE
- ⚠ Fraude à la feuille de soins (faux) → ordinal + correctionnel/pénal

□ Vu : M2023 Q12-13, M2021 Q10, M2018 Q25 (≥4×)

[RANG 32] INTRODUCTION À LA MÉDECINE LÉGALE

— • ~0.15 Q/examen

□ Source : med-legal-aio.pdf — Médecine légale FMPM

La réquisition & les missions civiles :

- Réquisition : ADMINISTRATIVE ou JUDICIAIRE ; c'est une INJONCTION (ordre) ; porte sur un fait médical
- Missions CIVILES : dommage corporel (AVP, AT), filiation, tutelle, détermination de l'âge en civil
- ⚠ La réquisition n'est PAS une expertise (l'expertise exige serment + rapport détaillé)
- ⚠ Examen du gardé à vue & agression sexuelle = missions PÉNALES (pas civiles)

□ Vu : N2025 Q48-49 (2×)

[RANG 33] CONTRAT MÉDICAL

— • ~0.08 Q/examen

□ Source : med-legal-aio.pdf — Médecine légale FMPM

Nature juridique du contrat médical :

- Contrat PERSONNEL (intuitu personae), SYNALLAGMATIQUE (obligations réciproques), consensuel, à cause LICITE
- ⚠ Ce n'est PAS un contrat de subordination ; ne concerne PAS le médecin fonctionnaire (régi par le droit administratif)

□ Vu : N2025 Q46 (1×)

PARTIE 4 — TOPICS HORS LEÇONS OFFICIELLES 2026 (COURS ANNULÉ)

⚠ DISCLAIMER — À LIRE AVANT D'UTILISER CETTE SECTION ⚠

These lessons are NOT in the 2026 exam program.

Cours annulé — NOT officially scheduled.

USE AT YOUR OWN RISK — BUT GOOD TO KNOW.

Ces topics représentaient historiquement ~0% des questions des examens passés. S'ils ne sont PAS au programme cette année, ils peuvent malgré tout :

- Apparaître en question résiduelle ou rattrapage
- Être recyclés à la dernière minute
- Servir de "culture générale" médicale

(Aucun topic hors programme — tous les topics correspondent aux leçons officielles cette année.)

AIDE-MÉMOIRE FINAL — HIGH-YIELD CONCOURS MÉDECINE LÉGALE · ÉTHIQUE · MÉDECINE DU TRAVAIL · DÉONTOLOGIE

** CADRES, LOIS & CLASSIFICATIONS À RETENIR **

4 principes de l'éthique	Bienfaisance · Non-malfaisance · Respect de la personne · Justice
3 principes de Belmont	Respect des personnes · Bienfaisance · Justice
3 principes radioprotection (CIPR)	Justification · Optimisation (ALARA) · Limitation
Éléments d'une infraction	Légal · Matériel · Moral
4 responsabilités du médecin	Pénale · Civile · Ordinale · Administrative
Systèmes de soins	Beveridgien (étatique) vs Bismarckien (assurantiel)
Lois marocaines clés	Loi 16-98 (transplantation) · Loi 77-17 (méd. légale) · Loi 131-13 (exercice)
Documents recherche	Nuremberg 1947 (consentement) · Helsinki 1964 · Belmont 1979

** SEUILS & CHIFFRES-CLÉS (très demandés) **

Marqueur / Critère	Indication
Datation ML (Vibert)	délai $\approx$ (37 – T° rectale) h
Surdit� professionnelle	d�ficit $\geq$ 35 dB sur la meilleure oreille
ITP — seuil de qualification	21 jours (> 20 j = d�lit)
D�claration AT	48 h (par l'employeur)
Visite de reprise obligatoire	absence sant� > 3 semaines
Sperme — positivit�	jusqu'� ~3 jours apr�s le rapport
Certificat de repos	$\leq$ 6 mois cons�cutifs
Infanticide	nourrisson < 1 an (d�rogation de peine pour la m�re)

** PI GES CLASSIQUES DU CONCOURS **

- ⚠ Belmont : justice =  VITER L'EXPLOITATION ($\neq$ minimiser les risques = non-malfaisance)
- ⚠ Fabrication (inventer) $\neq$ Falsification (manipuler) — ne jamais confondre
- ⚠ Le m decin NE QUALIFIE PAS l'infraction (r le du juge) — il constate/d crit
- ⚠ Bulletin de d c s : partie SUP RIEURE =  tat civil ($\neq$ statistiques, sans cause de mort)
- ⚠ Mort suspecte = CAUSE INCONNUE (l' ge avanc  n'est PAS un crit re)
- ⚠ Lividit s = zones D CLIVES ($\neq$ zones d'appui)
- ⚠ TMS atteignent muscles/tendons/nerfs mais PAS l'os
- ⚠ Surdit  = de PERCEPTION ($\neq$ transmission), bilat rale et sym trique
- ⚠ Responsabilit  p nale $\neq$ besoin syst matique d'un dommage physique
- ⚠ Donneur vivant $\neq$ « plus acceptable » que donneur en mort c r brale
- ⚠ Consentement : r vocable, oral possible, jamais facultatif
- ⚠ Euthanasie passive (arr t) $\neq$ active (administration l tale)

** PROC DURES & CH  NES   MA TRISER **

- Levée du corps : réquisition écrite → examen sur place → rapport ML → bulletin avec obstacle → transfert ML
- CAT AES : arrêter+sécuriser → laver eau/savon → antisepsie ≥5 min → sérologies source → déclarer AT (48 h)
- Certificat de décès : Partie I (a→b→c : immédiate→initiale) ; Partie II (états contributifs)
- Agression sexuelle : soins → consentement → prélèvements ML (jamais à la victime) → certificat + ITP → prophylaxie
- Maltraitance enfant : signalement Procureur (art. 446, secret levé) → hospitaliser+protéger → certificat ITP
- Mort encéphalique → don : refus exprimé du vivant ? → consentement présumé → équipe distincte du prélèvement
- MP indemnisable : tableau + CMI + délai respecté → présomption d'origine → indemnisation

Généré par Claude.ai (claude-opus-4-8) — Version 1

Cross-match 550 QEs officielles × Cours officiels FMPM : [ethique-aio.pdf](#) · [med-legal-aio.pdf](#) · [med-travail-aio.pdf](#)

Module transversal — FMPM Marrakech · corrections officielles e-qe.online

Améliorations Version 1 :

- ✓ 33 leçons classées par fréquence (550 QE, 13 sessions 2016→2025)
- ✓ PARTIE 3 strictement par rang (1 → 33), déduplication des questions répétées
- ✓ VRAI/FAUX explicites ([△](#)) extraits des corrections officielles e-qe.online
- ✓ Aide-mémoire transversal : cadres juridiques, seuils chiffrés, pièges, procédures
- ✓ Sources croisées : [ethique-aio.pdf](#) · [med-legal-aio.pdf](#) · [med-travail-aio.pdf](#)